

Obraz ciała w AvPD

„Widzę moje wady”. Nakładanie z BDD ~30–40%. **Wstyd cielesny** = rozszerzenie ogólnego wstydu. Praca: body appreciation + ekspozycja na bycie widzianym + defuzja.

CZAS: 12 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Bornstein (2005); Tylka (2015); Veale (2011)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz różnicę między AvPD a BDD w wymiarze ciała (sekcja 01). **2** · Poznasz mechanizm **selektywnej uwagi** na fragmenty ciała (sekcja 02). **3** · Zidentyfikujesz **swoje** wzorce unikania ciała (sekcja 03). **4** · Poznasz **cztery kroki pracy**: ekspozycja + body appreciation + CFT body scan + defuzja (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Negatywny obraz ciała jest **częstym, choć niedostrzeganym** wymiarem AvPD: pacjent czuje się **widzialny w wadach** — przekonany, że ludzie zauważają i oceniają jego wygląd. Bornstein (2005): silna korelacja klastra C zaburzeń osobowości z negatywnym obrazem ciała. Nakładanie z BDD (*Body Dysmorphic Disorder*) szacuje się na **30–40%**. Wstyd cielesny = **rozszerzenie** ogólnego wstydu („jestem wadliwy/-a wewnątrz i zewnątrz”). Różnica od BDD: w BDD = **specyficzna** wada (nos, skóra, włosy). W AvPD = **ogólne** poczucie nieatrakcyjności. Pacjent unika sytuacji odsłaniających ciało: basenu, plaży, bliskości fizycznej, jasnego światła. Każde lustro to ocena. Kompensacje: ukrywanie (luźne ubrania, włosy zasłaniające twarz), kontrola (godziny przed wyjściem), unikanie zdjęć. Schemat „wadliwy” zyskuje **cielesne potwierdzenie**. Tylka (2015, *body appreciation*): przesunięcie od wyglądu do funkcji ciała — od ciała-objektu do ciała-domu.

01



AvPD vs BDD — różny obraz ciała

BDD — SPECYFICZNA WADA

„Mój nos jest deformowany”. „Moja skóra”. Konkretny fragment. Godziny przed lustrem, sprawdzanie. Możliwe operacje plastyczne. Skupienie *punktowe*.

AVPD — OGÓLNY BRAK ATRAKCYJNOŚCI

„Jestem brzydki/-a”. Bez konkretnego. Całe ciało źle wygląda, źle się porusza. Unikanie luster — nie godziny przed nimi. Skupienie *rozproszone*.

Nakładanie 30–40% (Bornstein 2005): pacjent z AvPD może **dodatkowo** mieć BDD na jakimś fragmencie. Wtedy oba schematy działają równolegle. Ważne dla planu terapii: czy adresujemy ogólny wstyd cielesny (AvPD), czy specyficzną wadę (BDD), czy oba.

02 © Selektywna uwaga — mechanizm zniekształcenia

MIRROR CHECKING — krótko
skupienie na

fragmentach — wady „wystają” **SPOJRZENIE Z DYSTANSU** *cała postać — wady się integrują, kontekst* **MIRROR RETRAINING (VEALE 2011)** *trening — dłuższe spojrzenie, opisowe, neutralne, na całość zamiast wad*

Mechanizm: selektywna uwaga skupia się na *fragmentach* ciała ocenianych jako wadliwe — co wzmacnia ich percepcję jako „wystających”, „widocznych”. *Mirror checking* w krótkich rzutach pogłębia ten efekt — każdy rzut potwierdza wadę. Spojrzenie z dystansu, na całą postać, w dłuższym czasie, działa *odwrotnie* — integruje, kontekstualizuje. Veale 2011 (*mirror retraining*): trening dłuższego, neutralnego patrzenia jest skuteczną interwencją.

03 ✎ Moje wzorce unikania ciała

SYTUACJE, KTÓRE UNIKAM

— basen, plaża, jasne światło, bliskość fizyczna?

KOMPENSACJE — CO DOSŁOWNIE ROBIĘ?

— ubrania, fryzura, zdjęcia, lustra

MÓJ „NAJGORSZY” FRAGMENT CIAŁA

— konkretny czy ogólne „wszystko”?

CO MOJE CIAŁO POTRAFI?

— funkcja, nie wygląd

04 💡 Cztery kroki pracy z obrazem ciała

1 • EKSPOZYCJA NA BYCIE WIDZIANYM

Stopniowo: spojrzenia w lustro → fotografia → bycie fotografowanym → odsłonięcie ciała (basen). Hierarchia analogiczna do społecznej.

2 • BODY APPRECIATION (TYLKA 2015)

Od *wyglądu* do *funkcji*: co moje ciało potrafi? Daje życie, oddycha, niesie. Ciało jako **dom**, nie wystawowy obiekt.

3 • CFT BODY SCAN

Współczujący skan ciała: ciepło i akceptacja dla każdej części. Wstyd cielesny ustępuje pod współczującym dotykiem (CFT Gilbert).

4 • DEFUZJA (ACT)

„Mam myśl, że jestem brzydki/-a” — to myśl, nie fakt. Defuzja od myśli o ciele zamiast walka z nimi.

Klucz: sama korekta percepcji ciała („nie jesteś wadliwy fizycznie”) *nie wystarcza* w AvPD — bo schemat „jestem wadliwy” znajdzie inny obszar do projekcji (głos, sposób mówienia, „energię”). Praca z obrazem ciała jest skuteczna **gdy pacjent pracuje ze schematem defektywności równolegle**. Cel: ciało jako *dom*, nie wystawowy obiekt do oceny. Body appreciation (Tylka 2015): przesunięcie od *wyglądu* do *funkcji*. Veale 2011 (*mirror retraining*): trening dłuższego, neutralnego patrzenia. Eksperyment behawioralny: zapytaj 5 osób co zapamiętali z ciebie — zwykle odpowiedzi *nie* dotyczą wad, na których pacjent fiksuje.